PLAN DE SUIVI-ÉVALUATION

Nutrition à assise communautaire • Redevabilité • Apprentissage

Consortium SANRU–ICHESS–FONLIV–FDSS | Chef de file : SANRU

Province du Kwilu, République démocratique du Congo
Période : 1er janvier 2027 – 31 décembre 2028
Édition : 6 novembre 2026 | Statut : proposition technique pour validation

Source principale : Tech-4 (Récupération automatique).docx — DP n° ZR-DRC-MSP-235334-CS-QCBS.

Les cibles proposées ne sont pas des engagements contractuels approuvés. Les données anciennes du TECH-4 ne constituent pas des références 2027. Validation conjointe requise au plus tard le 31 mars 2027.

Guide de lecture et validation

Ce plan organise le suivi des quatre objectifs du TECH-4 sur 24 mois. Il est accompagné d'un cadre de performance autonome, aux formats Word et PDF, qui contient les définitions et fiches des 26 indicateurs. Les deux documents doivent être approuvés ensemble. Les activités initialement décrites dans un contexte 2021–2022 sont reprogrammées, sans présumer de la continuité des financements ou des personnels cités.

Rubrique	Contenu
1–3	Périmètre, réserves et logique des résultats
4–7	Gouvernance, information, qualité et indicateurs
8–11	Évaluations, surveillance, redevabilité et apprentissage
12–15	Calendrier, budget, risques et outils de gestion

Visa requis	Responsabilité de validation
SANRU / consortium	Faisabilité opérationnelle et financière ; répartition des tâches
DPS Kwilu / PRONANUT	Normes techniques, répertoires, intégration SNIS et SNSAP
ECZS des 10 ZS	Dénominateurs, déploiement, circuits de remontée
UG-PDSS / autorité contractante, selon mandat actualisé	Alignement contractuel ; calendrier et cibles
Protection des données / éthique	Sécurité, consentement et protocoles de recherche

1. Périmètre et diagnostic documentaire

Le TECH-4 vise l'amélioration de l'accès, de l'utilisation et de la qualité des services de nutrition et de santé communautaires, avec un volet VBG et un renforcement du système de santé. Le suivi couvre les enfants de moins de cinq ans, particulièrement les moins de deux ans, les femmes enceintes et allaitantes, les ménages et les structures communautaires et sanitaires. Les adolescents et les groupes vulnérables sont inclus dans les activités pertinentes de prévention et de protection.

Zones de santé citées : Djuma, Kingandu, Moanza, Kimputu, Sia, Pay-Kongila, Yasa Bonga, Mosango, Gungu et Kikwit Nord. Les variantes Yassa/Bonga Yassa et Pay Kongila devront être harmonisées avec les codes officiels de la DPS.

Élément du TECH-4	Traitement pour 2027–2028
10 ZS ; 250 AS ; 190 SSC ; 423 FOSA	Périmètre de planification à confirmer par répertoire géocodé à M3 ; distinguer AS, FOSA, SSC et CAC.
3 188 CAC ; passage mentionnant 2 250/2 188 et 71 %	Incohérence arithmétique et de dénominateur : ne pas reprendre comme couverture initiale ; inventorier villages et CAC actives/inactives.
415 695 ménages ; 8 314 RECO estimés ; 4 956 prioritaires + 3 358 restants	Effectifs historiques non actualisés ; 4 956 constitue le volume prioritaire repris pour la planification de formation, non un effectif déjà disponible.
47 % de retard de croissance ; AME 32,7 % ; diversité 27,1 %	Repères historiques uniquement. Vérifier année, population et définition ; réaliser une référence initiale comparable.
Données 2021–2022, primes et montants historiques	Pas d'extrapolation en coûts 2027 ; vérifier ressources, normes, partenaires et conditions contractuelles.

2. Finalité, questions et principes du suivi-évaluation

Finalité : produire des informations fiables et utilisables pour piloter l'équité de couverture, la qualité, la sécurité et la pérennité des services. Le dispositif doit rester proportionné aux capacités locales et alimenter le SNIS plutôt que créer une chaîne parallèle.

• Les services atteignent-ils les enfants et ménages attendus, y compris les plus éloignés et ceux en situation de handicap ?

• Les prestataires sont-ils compétents, équipés et soutenus ? Les références nutritionnelles aboutissent-elles ?

• Les pratiques ANJE et d'hygiène évoluent-elles, et quels facteurs expliquent les changements ou leur absence ?

• La participation communautaire, la prévention des VBG et les mécanismes de recours fonctionnent-ils sans exposer les personnes ?

• Les données sont-elles exactes, ponctuelles et utilisées pour lever les goulots d'étranglement ? Quels acquis peuvent être maintenus après décembre 2028 ?

3. Théorie du changement et chaîne de résultats

Si le consortium et la DPS rendent disponibles des RECO compétents, des intrants, des structures communautaires actives, des soins de qualité et des circuits de protection sûrs, et si les ménages participent aux décisions et reçoivent des conseils adaptés, alors l'accès, l'utilisation continue et la qualité des services progresseront. Les pratiques alimentaires et d'hygiène pourront s'améliorer et contribuer à une meilleure situation nutritionnelle. Cette contribution dépend aussi de la sécurité alimentaire, des revenus, des épidémies et de l'accès à l'eau ; elle ne prouve pas une attribution causale au seul projet.

Niveau	Résultats attendus	Mesures clés
Intrants / activités	Formation, équipement, supervisions, soutien communautaire, SNIS	P02, P03, P15
Produits OS1	Paquet NAC, SSC intégrés, dépistage et référence, innovations	P01, P04–P07
Produits OS2	Prévention et circuits VBG sûrs ; compétences d'accueil	P08, P09
Produits OS3	CAC fonctionnelles, MAA, décisions suivies	P10–P12
Produits OS4	FOSA renforcées, qualité, SNSAP et système S&E	P13–P19, P22
Effets transversaux	Pratiques ANJE/hygiène, satisfaction et redevabilité	EFF01–EFF03, P20–P21
Impact / contribution	Évolution du retard de croissance ; interprétation prudente	IMP01

4. Gouvernance et responsabilités

Acteur	Fonctions et livrables
Coordination SANRU / consortium	Redevable de l'ensemble ; arbitre moyens et corrections ; valide les rapports ; prévient les doubles financements. Les rôles par membre sont formalisés par convention à M1.
Responsable S&E et gestionnaire des données	Dictionnaire, outils, base, formation, contrôles, tableaux de bord, rapports et journal des corrections ; administration des accès avec le référent informatique.
DPS / PRONANUT	Validation nutrition et SNSAP ; supervision provinciale, consolidation, revue semestrielle et appropriation.
ECZS / gestionnaire SNIS	Validation mensuelle, saisie DHIS2 selon droits, supervision AS/FOSA, retour aux équipes et MAA trimestriel.
IT, FOSA et SSC	Tenue des registres, confirmation des orientations, stocks, rapports et contrôles de premier niveau.
RECO / CAC / CODESA	Dénombrement, contacts, dépistage selon normes, références, réunions et restitution locale de données agrégées.
Référent protection / VBG	Gestion indépendante des données sensibles, sécurité des circuits, soutien aux prestataires ; aucune diffusion nominative au tableau de bord.
Évaluateur / vérificateur indépendant	Enquêtes initiale/finale et vérification externe ; déclare ses conflits d'intérêts et protège l'indépendance des conclusions.

La séparation collecte–validation–paiement est obligatoire si un financement basé sur la performance est activé. Les paiements ne seront pas fondés sur les volumes VBG ni sur des données non vérifiées. Le comité de pilotage valide les changements de cibles sans réécrire rétrospectivement les résultats.

5. Architecture du système d’information

Circuit : ménage → RECO/CAC → IT/AS et FOSA/SSC → ECZS/SNIS → DPS/PRONANUT et coordination du consortium → autorité contractante selon les dispositions actualisées. Les agrégats compatibles sont intégrés à DHIS2 via les canaux autorisés. Le registre électronique communautaire est un pilote conditionné à la connectivité, aux moyens et à la validation ministérielle ; le papier reste une solution de continuité.

Échéance proposée, mois M+1	Opération
J1–J5	RECO/CAC et FOSA rapprochent les registres, dédupliquent et transmettent les synthèses du mois M.
J6–J10	IT et ECZS contrôlent sources, écarts, cohérence et accusés de réception.
J11–J15	Validation et intégration SNIS/DHIS2 ; retour des erreurs et données manquantes.
J16–J20	Consolidation consortium/DPS, tableau de bord et rapport mensuel.
Au plus tard J30 après trimestre	Rapport trimestriel et plan d’amélioration ; délais contractuels à confirmer.

Ce calendrier est une proposition, à remplacer par les échéances officielles si elles diffèrent. Chaque enregistrement de service porte un identifiant non signifiant, la date, le site, le type de prestation et les variables minimales. Un registre protégé local permet le suivi individuel ; seules les données nécessaires sont remontées. L’identification nationale n’est pas une condition d’accès au service.

Dénominateurs : dénombrement initial, réconciliation avec les données officielles, puis actualisation trimestrielle des naissances, décès et migrations. Chaque version est datée et conserve l’historique. Les bénéficiaires uniques, les contacts répétés et les ménages sont des unités distinctes. Un transfert entre sites ne crée pas un nouveau bénéficiaire à l’échelle du projet. Les rapports zéro sont explicites ; les données manquantes ne sont pas imputées à zéro.

6. Qualité, sécurité et traçabilité des données

À chaque niveau : contrôler complétude, promptitude, validité des plages, cohérence inter-indicateurs et exactitude par retour aux sources. Toute couverture > 100 %, variation mensuelle > 20 % sans explication ou discordance > 10 % déclenche une vérification, et non une correction automatique. Ces seuils sont proposés et doivent être adaptés aux petits effectifs et à la saisonnalité.

Audit trimestriel proposé : trois AS par ZS, sélectionnées selon risque avec une composante aléatoire et rotation ; auditer au moins une FOSA et deux CAC par AS (30 FOSA et 60 CAC par passage si le répertoire le permet). Recompter trois traceurs sur les trois mois précédents. Couvrir progressivement les zones éloignées et le privé. Un audit ciblé est déclenché en cas de suspicion ; une vérification externe est prévue à M12 et M24. Cet échantillon d’audit n’est pas une enquête représentative des résultats populationnels.

Chaque anomalie reçoit un numéro, une cause, une valeur d’origine, une correction justifiée, un valideur et une date. Le responsable local corrige sous 10 jours ouvrables, l’ECZS recontrôle sous 30 jours. Les tableaux publiés portent le statut provisoire/validé et la version des dénominateurs.

Sécurité : accès selon rôle, authentification renforcée si disponible, chiffrement des appareils et transferts, sauvegardes hebdomadaires et test de restauration trimestriel. Données nominatives séparées des agrégats ; aucun nom dans les rapports ni transfert de listes par messagerie non sécurisée. À M2, approuver la durée de conservation selon exigences légales, éthiques et contractuelles ; supprimer ou anonymiser les identifiants dès qu’ils ne sont plus nécessaires. Incident : sécurisation immédiate, notification au responsable sous 24 h et évaluation du risque aux personnes.

7. Indicateurs, références et règles de lecture

Le cadre de performance associé comprend 26 indicateurs : un de contribution à l’impact, trois d’effets et 22 de produits/gestion. Chaque fiche précise formule, référence, cibles annuelles, source, fréquence, responsable, désagrégations et précautions. B désigne la valeur initiale mesurée en 2027. Les cibles d’effets sont exprimées en points de pourcentage, pas en pourcentage relatif.

Statut des cibles : tous les seuils de performance et trajectoires sont des propositions de planification, sauf les volumes de périmètre explicitement tirés du TECH-4 ; même ces volumes nécessitent confirmation. À M3, la DPS et le consortium révisent leur faisabilité au regard de B, du budget et du calendrier de déploiement. Un avenant au cadre documente valeur ancienne, nouvelle, raison et approbateur.

Les cibles de couverture et de qualité annuelles désignent le dernier trimestre ou le dernier mois validé de l'année selon la fréquence, avec affichage complémentaire de la moyenne annuelle. Les volumes de personnes formées sont cumulés ; les revues sont des flux annuels ; les structures intégrées sont des effectifs à date. Les cibles intermédiaires sont détaillées dans le cadre, sans confondre ces unités.

8. Plan d'évaluation et stratégie d'échantillonnage

Moment	Questions / méthode	Produit et usage
Initiale : janvier–mars 2027, M1–M3	Inventaire des structures et RECO ; enquête ménages ANJE/WASH/anthropométrie ; audit FOSA ; qualitatif sur barrières et sécurité.	Références B, répertoires validés et recalibrage avant le 31 mars. Démarrage des services urgents non retardé ; exposition précoce documentée.
Mi-parcours : décembre 2027, M12	Revue de processus et coûts ; audit externe des données ; entretiens et analyse équité. Sondage d'effets seulement si financé et suffisamment précis.	Rapport de performance et décisions de réallocation ; plan correctif janvier 2028.
Finale : octobre–décembre 2028, M22–M24	Enquête comparable à l'initiale, audit qualité, analyse de contribution et durabilité ; vérification indépendante.	Rapport final en décembre 2028, limites explicites et plan de transfert. Ajustement saisonnier ou réserve sur la comparabilité.

Plan quantitatif proposé : sondage en grappes à deux degrés, sélection des grappes proportionnelle à la population, puis sélection aléatoire des ménages sur listes actualisées ; aucune substitution de convenance. L'estimation principale porte sur l'ensemble des dix ZS. Une estimation représentative par ZS exige un dimensionnement additionnel ; les ventilations ne seront pas présentées comme précises si l'effectif ne le permet pas.

Exemple de dimensionnement, non taille définitive : pour une proportion de 50 %, précision absolue de 5 points, confiance 95 %, effet de plan 1,5 et 10 % de non-réponse, $n = (1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}05^2) \times 1{,}5 / 0{,}90 \approx 641$ observations éligibles. Ce nombre n'est pas celui des ménages : convertir selon la prévalence attendue de chaque groupe d'âge. L'AME chez les 0–5 mois requiert son propre effectif. Une précision de 5 points par passage ne garantit pas la puissance pour détecter 10 points de changement ; calculer séparément la puissance de comparaison et retenir le besoin maximal compatible avec les ressources.

Anthropométrie : protocole SMART adapté et validé par PRONANUT, mesure du poids, de la taille/longueur, du PB et des œdèmes selon âge et normes nationales ; double mesure et standardisation des enquêteurs ; contrôle quotidien des appareils et de la plausibilité. Les modules ANJE exigent un protocole complémentaire : une enquête SMART seule ne garantit pas leur précision. Consentement éclairé, assentiment approprié et référence immédiate des cas nécessitant des soins.

Analyse : pondération, grappes et strates prises en compte ; proportions et intervalles de confiance à 95 %, différences en points, données manquantes et taux de réponse publiés. Qualitatif raisonné auprès de femmes, hommes, jeunes, RECO, prestataires et ménages éloignés jusqu'à suffisance thématique. Une comparaison avant/après sans contrefactuel ne permet pas d'attribution causale. Documenter prix alimentaires, chocs, épidémies et interventions des partenaires.

Saisonnalité : la fenêtre initiale janvier–mars et la finale octobre–décembre ne sont pas parfaitement superposables. Les équipes doivent rechercher les semaines les plus proches du cycle saisonnier, documenter les pluies, récoltes et accès alimentaire, et éviter de conclure à un effet du projet sur une différence brute. Tout suivi en janvier–mars 2029 nécessiterait une autorisation et un financement distincts ; il n'est pas inclus dans le présent calendrier.

9. Surveillance nutritionnelle et alertes

Consolider mensuellement les 20 sites sentinelles envisagés, sous réserve de confirmation, et les signaux communautaires. Le PRONANUT applique les seuils SNSAP nationaux en vigueur ; aucun seuil épidémiologique

n’est inventé ici. Une hausse inhabituelle de dépistages positifs, des décès signalés ou une rupture prolongée déclenche la vérification ECZS sous 48 heures proposée, puis une investigation selon les normes nationales. L’absence de rapport d’un site est une alerte de fonctionnement, pas une absence de risque nutritionnel.

Le dépistage communautaire et les données sentinelles ne sont pas utilisés pour estimer la prévalence populationnelle. Les cas graves ou présentant des signes de danger sont orientés sans attendre la validation des données ni la revue mensuelle. Les seuils cliniques, traitements et critères d’admission suivent le protocole national actualisé.

10. Redevabilité, VBG et approche centrée sur la personne

Mettre à disposition des canaux gratuits et accessibles : entretien confidentiel, point focal formé, boîte ou téléphone selon faisabilité et langues locales. Informer sur les délais, recours et absence de représailles. Les plaintes non sensibles sont accusées sous 72 heures proposées et traitées sous 30 jours ; une restitution anonymisée trimestrielle présente les thèmes et corrections.

Les plaintes VBG, exploitation/abus sexuels et harcèlement suivent exclusivement un circuit spécialisé et confidentiel. Ni CAC ni comité de plaintes ne doit enquêter, imposer une conciliation ou solliciter une dénonciation publique. Cette sauvegarde prévaut sur toute formulation de médiation générale dans le document source. Le consentement de la personne et les obligations légales de protection, notamment pour les enfants, sont traités par les professionnels habilités ; expliquer les limites de confidentialité.

Ne pas inclure de questionnaire de prévalence VBG dans l’enquête générale sans protocole spécifique, équipe qualifiée, mécanismes de référence et approbation éthique. Ne pas faire du nombre de cas rapportés un indicateur de succès ou d’échec. Ne diffuser que des agrégats non identifiants ; masquer les cellules inférieures à cinq et celles permettant une identification par recoupement. Les données cliniques sensibles restent chez le prestataire autorisé.

11. Analyse, apprentissage et utilisation

Le tableau de bord mensuel affiche résultat, cible de période, dénominateur, qualité, évolution et décision attendue. Le MAA trimestriel applique la cascade Tanahashi : disponibilité, accessibilité, utilisation initiale, continuité et qualité. Chaque goulot prioritaire donne lieu à une action avec responsable, budget, échéance et preuve de clôture.

Feux proposés pour indicateurs croissants à cible positive : vert ≥ 95 % de la cible, orange 80–<95 %, rouge <80 %. Pour les proportions plafonnées, interpréter aussi l’écart en points. Indicateurs sans cible chiffrée d’impact : pas de feu artificiel. Une alerte de sécurité ou de qualité critique impose une action même si les volumes sont au vert. Ne pas agréger ces feux en classement des ZS sans tenir compte du contexte.

Les revues provinciales ont lieu en juin et décembre de chaque année. Deux recherches opérationnelles proposées portent sur le suivi numérique des ménages et le coaching des RECO, selon financement. Documenter faisabilité, coût, accès équitable, acceptabilité et protection des données ; ne déployer à grande échelle qu’après examen des résultats. Produire un bulletin trimestriel accessible et au moins deux notes de capitalisation sur la période.

12. Chronogramme opérationnel 2027–2028

Activité / responsable	T1 27	T2 27	T3 27	T4 27	T1 28	T2 28	T3 28	T4 28
Outils, référence, répertoires / S&E-DPS	X	MAJ	MAJ	MAJ	MAJ	MAJ	MAJ	MAJ
Formation et suivi à 3 mois / ECZS	X	X	X	X	X	X	X	X
Collecte et tableau de bord / tous niveaux	M	M	M	M	M	M	M	M
MAA et audit données / ECZS-S&E	Dém.	X	X	X	X	X	X	X
Revues provinciales / DPS		X		X		X		X

Activité / responsable	T1 27	T2 27	T3 27	T4 27	T1 28	T2 28	T3 28	T4 28
Mi-parcours / évaluateur				X				
Évaluation finale / évaluateur							Prépa.	X
Capitalisation / coordination			X					X
Transfert et clôture / coordination-DPS						X	X	X

M = chaque mois ; MAJ = mise à jour ; Dém. = démarrage. De janvier à mars 2027 : nomination des responsables à M1, validation des outils à M2, référence et cadre révisé à M3. À partir de juin 2028, préparer les responsabilités, coûts récurrents, licences, supports, accès et actifs à transférer. Un test de gestion autonome est organisé au dernier trimestre 2028.

13. Budget indicatif du suivi-évaluation

Budget de planification en USD, hors taxes éventuelles, non extrait du TECH-4 et non approuvé. Les coûts doivent être établis par devis, barèmes applicables et plan d'échantillonnage final. Le personnel permanent, les formations techniques NAC et les intrants de soins sont exclus pour éviter les doubles comptes. Les jours de consultant et frais terrain doivent être précisés avant engagement.

Poste	Base proposée	2027 USD	2028 USD	Total
Référence initiale multi-thématique	1 × 35 000	35,000	0	35,000
Revue de mi-parcours indépendante	1 × 12 000	12,000	0	12,000
Évaluation finale comparable	1 × 35 000	0	35,000	35,000
Audits trimestriels et MAA : appui marginal	8 × 2 000	8,000	8,000	16,000
Revues provinciales semestrielles	4 × 3 000	6,000	6,000	12,000
Outils, formation S&E et référentiels	2 lots : 6 000 + 2 000	6,000	2,000	8,000
Gestion des données, hébergement et sauvegardes	24 × 250	3,000	3,000	6,000
Vérification externe qualité / performance	2 × 5 000	5,000	5,000	10,000
Redevabilité et enquêtes satisfaction	4 × 1 500	3,000	3,000	6,000
Capitalisation et diffusion	2 × 2 000	2,000	2,000	4,000
Sous-total		80,000	64,000	144,000
Provision 10 % (indicative)		8,000	6,400	14,400
Total indicatif		88,000	70,400	158,400

La suffisance des 35 000 USD par enquête n'est pas garantie, notamment pour des estimations par ZS ou des sous-groupes rares. Les tablettes, la connectivité de masse, les effectifs S&E permanents et les coûts des études pilotes doivent être budgétés séparément si non disponibles. Calculer ensuite la part S&E du budget total ; celui-ci n'étant pas fourni et actualisé, aucun pourcentage n'est affirmé. La provision ne remplace pas une autorisation contractuelle de dépense.

14. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Mesure / responsable / signal
Dénominateurs obsolètes et doubles comptes	Dénombrement M1–M3, versions trimestrielles et identifiants ; S&E/ECZS ; couverture > 100 %.
Enclavement et saison des pluies	Plan logistique, papier hors ligne, collecte anticipée ; coordination ; retards récurrents par AS.
Rupture d'intrants ou retrait d'un partenaire	Stocks traceurs, coordination logistique, plan de continuité ; pharmacien ; jours de rupture.

Risque	Mesure / responsable / signal
Départ des RECO ou surcharge	Cohortes, coaching, simplification outils, budget de remplacement ; engagement communautaire ; attrition.
Incitation à sur-déclarer	Vérification indépendante et séparation paiement/validation ; coordination ; écart audit > 10 %.
Fuite de données ou préjudice VBG	Minimisation, accès limités, circuit spécialisé et réponse incident ; protection ; tout incident critique.
Budget insuffisant pour enquêtes	Prioriser estimation globale et audit ; recalculer précision ; comité de pilotage ; devis supérieur au plafond.
Variation saisonnière et facteurs externes	Documenter chocs et limites ; évaluateur ; fenêtres non comparables.

15. Outils opérationnels et clôture

Outil minimum	Champs obligatoires
Répertoire des structures	Code officiel, ZS/AS, type, village, statut, coordonnées si sûr, date de validation et historique.
Registre bénéficiaires / contacts	Identifiant protégé, âge/sexe, résidence, date, service, orientation et retour ; accès local contrôlé.
Fiche supervision / post-formation	Site, date, grille, erreurs critiques, score, action, responsable et délai.
Tableau de bord mensuel	Indicateur, numérateur, dénominateur/version, résultat, cible, qualité, commentaire et action.
Plan d’amélioration MAA	Goulot, cause, mesure, coût, responsable, échéance, statut et preuve de clôture.
Registre correction / incidents	Valeur initiale, justification, correcteur, valideur, horodatage ; incident sensible dans registre séparé.
Suivi budgétaire S&E	Ligne, prévision, engagement, dépense, écart, activité et financeur.

À la clôture : validation finale des bases, archivage contrôlé, remise des outils et dictionnaires à la DPS, inventaire des matériels transférés et procès-verbal de réception. Définir qui assure les rapports, sauvegardes, supervisions et consommables à partir de janvier 2029. Produire un rapport de durabilité avec engagements réalistes, sans présumer d’un financement futur.

Références et limites documentaires

Source primaire consultée : Tech-4 (Récupération automatique).docx, sections « Objectifs spécifiques » 1 à 4, résultats intermédiaires 1.1–1.3, 3.1–3.3, 4.1–4.5 et passages sur le S&E, MAA, SMART et SNSAP. Les statistiques historiques sont rapportées par cette source, sans vérification des enquêtes originales. Les numéros de pages ne sont pas utilisés car ils varient selon la récupération et la mise en page du fichier.

Référentiel technique à joindre lors de la validation : OMS/UNICEF, Indicators for assessing infant and young child feeding practices, 2021 ; normes OMS de croissance de l’enfant ; guides SMART en vigueur ; outils nationaux SNIS/DHIS2, SNSAP et protocoles PCIMA/NAC actualisés. Ces textes externes ne sont pas présentés comme ayant été vérifiés dans leur dernière édition nationale. Les obligations et normes applicables en 2027 doivent être confirmées par les autorités compétentes.